**Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition**

Vol. 3 (2026)
Chapitre 4

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



# Pratiques et comportements alimentaires

*Food practices and eating behaviour*

**REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE**

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 4

*Fiche de synthèse · Fact sheet*

# Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 4

## Pratiques et comportements alimentaires

*Food practices and eating behaviour*

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

**INFORMATIONS**

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 4

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

**MOTS-CLÉS / KEYWORDS**

Rôles de l'acte alimentaire; Régulation; Pratiques actuelles

**RÉSUMÉ STRUCTURÉ**

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. décrire les rôles de l'acte alimentaire (biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique) ; définir le comportement alimentaire et les notions de besoin, d'oralité et de pulsion ; expliquer la régulation du comportement alimentaire (faim, rassasiement, satiété ; régulation homéostatique et hédonique) et ses dérégulations (restriction cognitive, alimentation émotionnelle, troubles du comportement alimentaire) ; identifier les déterminants du comportement alimentaire d'un individu pour construire analyses, conseils et actions éducatives (objectif du guide 2025) ; décrire l'évolution des pratiques alimentaires en France et le syncrétisme culinaire ; présenter les principales pratiques alimentaires actuelles (végétarisme, flexitarisme, végétalisme, pratiques religieuses, régimes d'exclusion, alimentation durable) et leurs points de vigilance.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les rôles de l'acte alimentaire ; 3. Pratiques et vigilance ; 4. Chiffres-clés ; 5. Les pièges ; 6. Auto-test ; 7. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe ; O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

**ABSTRACT**

*Food practices and eating behaviour. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.*

**POINTS CLÉS**

■ décrire les rôles de l'acte alimentaire (biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique) ;

■ définir le comportement alimentaire et les notions de besoin, d'oralité et de pulsion ;

■ expliquer la régulation du comportement alimentaire (faim, rassasiement, satiété ; régulation homéostatique et hédonique) et ses dérégulations (restriction cognitive, alimentation émotionnelle, troubles du comportement a

■ identifier les déterminants du comportement alimentaire d'un individu pour construire analyses, conseils et actions éducatives (objectif du guide 2025) ;

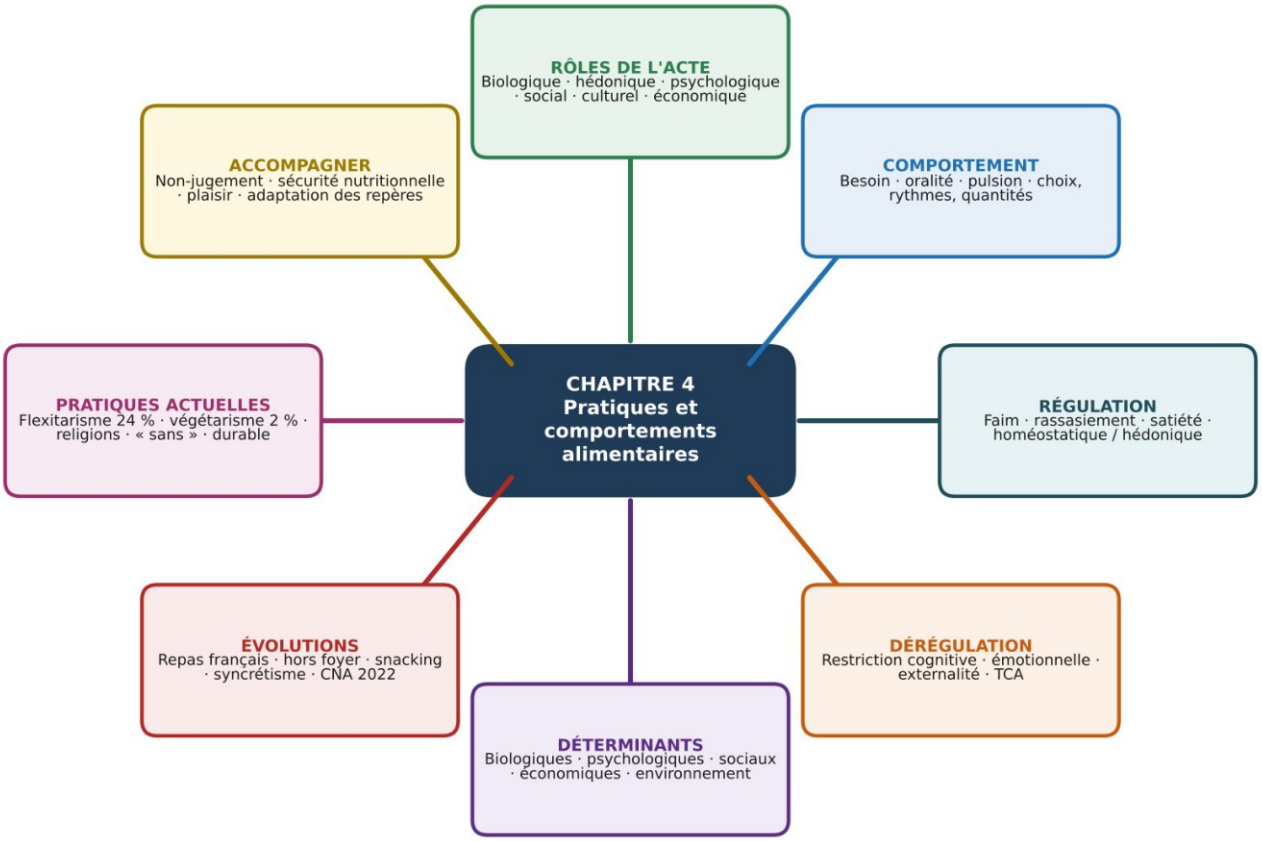
■ décrire l'évolution des pratiques alimentaires en France et le syncrétisme culinaire ;

# Sommaire

**Fiche de révision du chapitre 4** ..... 4
1. Les définitions à savoir ..... 4
2. Les rôles de l'acte alimentaire ..... 4
3. Pratiques et vigilance ..... 4
4. Chiffres-clés ..... 4
5. Les pièges ..... 5
6. Auto-test ..... 5
7. Flashcards ..... 5
Compléments du chapitre enrichi ..... 5
**Fiches-outils du chapitre 4** ..... 5
O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe ..... 5
O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété ..... 5
O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire ..... 6
O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe ..... 6
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir ..... 6

# Fiche de révision du chapitre 4

*Pratiques et comportements alimentaires*




*Carte mentale du chapitre 4*

## 1. Les définitions à savoir

| Notion · Définition |
|---|
| **Comportement alimentaire** — *Définition :* Conduites vis-à-vis de l'alimentation : choix, prises, rythmes, quantités, contexte |
| **Faim / rassasiement / satiété** — *Définition :* Avant (ghréline) / pendant, arrêt de la prise (CCK, distension) / après, jusqu'au repas suivant (GLP- 1, PYY, insuline, leptine) |
| **Régulation homéostatique / hédonique** — *Définition :* Hypothalamus, équilibre énergétique / récompense, dopamine, plaisir |
| **Restriction cognitive** — *Définition :* Règles mentales au lieu des sensations (Herman et Polivy, 1975) |
| **Externalité** — *Définition :* Manger en réponse à des signaux extérieurs |
| **Syncrétisme culinaire** — *Définition :* Combinaison de cultures culinaires |
| **Flexitarisme** — *Définition :* Réduction volontaire de la viande (24 % en 2020) |

## 2. Les rôles de l'acte alimentaire

Biologique · hédonique · psychologique · social · culturel et identitaire · économique.

## 3. Pratiques et vigilance

| Pratique · Point de vigilance clé |
|---|
| **Végétarisme** — *Point de vigilance clé :* Fer (+ vitamine C), oméga-3, zinc, iode |
| **Végétalisme** — *Point de vigilance clé :* Vitamine B12 : supplémentation obligatoire ; calcium, vitamine D, iode, protéines |
| **Religions** — *Point de vigilance clé :* Respect des interdits ; Ramadan : hydratation, repas de rupture équilibré |
| **« Sans gluten » sans diagnostic** — *Point de vigilance clé :* Pas de bénéfice démontré, surcoût |
| **Régimes à la mode, jeûne** — *Point de vigilance clé :* Restriction, carences, TCA |

## 4. Chiffres-clés

- Part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) (Insee, 2015) ; 12,5 % en 2025 pour les seuls aliments et boissons non alcoolisées (Insee, 2026).
- 2 % de végétariens/végétaliens, 24 % de flexitariens, 8 % limitant la viande (Ifop/FranceAgriMer, 2020).
- Néophobie maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions.
- Repas gastronomique des Français : UNESCO 2010.

## 5. Les pièges

> **Attention**
> - Confondre rassasiement et satiété.
> - Prescrire ou encourager des régimes restrictifs en santé publique.
> - Classer des aliments en « interdits ».
> - Juger une pratique (végétarisme, religion) au lieu de la sécuriser.
> - Poser un diagnostic de TCA (on repère et on oriente).

## 6. Auto-test

**1.** Hormone de la faim ? 2. Hormone des réserves ? 3. Moment du rassasiement ? 4. Étapes du cercle de la restriction ? 5. Nutriment à supplémenter chez le végétalien ? 6. Part des flexitariens ? 7. Qu'est-ce que l'externalité ? 8. Deux conseils pour favoriser le rassasiement ? 9. Que signifie ARFID ? 10. Exemple de syncrétisme ?

*Réponses : 1. Ghréline – 2. Leptine – 3. Pendant le repas – 4. Insatisfaction, restriction, frustration, craquage, culpabilité, reprise de poids – 5. Vitamine B12 – 6. 24 % – 7. Manger selon des signaux extérieurs – 8. Manger lentement, fibres et protéines, sans écran – 9. Trouble de restriction/évitement de l'ingestion des aliments – 10. Couscous aux légumes de saison français.*

## 7. Flashcards

**Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ? · Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres**

**Recto : Environnement obésogène ?** — *Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres :* Verso : Portions, offre palatable, marketing, sédentarité

**Recto : Loi d'Engel ?** — *Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres :* Verso : La part de l'alimentation dans le budget baisse quand le revenu augmente

**Recto : Recommandations HAS TCA ?** — *Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres :* Verso : Anorexie mentale (2010) ; boulimie et hyperphagie boulimique (2019)

**Recto : Cinq principes d'accompagnement ?** — *Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres :* Verso : Comprendre, respecter, partir de l'existant, plaisir, sécuriser et orienter

**Recto : Facilitation sociale ?** — *Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres :* Verso : On mange plus à plusieurs : utile contre la dénutrition

## Compléments du chapitre enrichi

**Notion · À retenir**

**Rythmes** — *À retenir :* Repas, collation (prévue, faim), grignotage ; petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; pas de collation à 10 h si petit-déjeuner (AFSSA, 2004)

**Enfant** — *À retenir :* Diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; Satter : parent quoi/quand/où, enfant si/combien

**Mesure** — *À retenir :* Rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes

**Durabilité** — *À retenir :* FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019, mise à jour 2025) ≈ 14 g/jour de viande rouge ; bœuf ≈ 50 × lentilles en CO2e par portion ; gaspillage ≈ 3,8 Mt comestibles en 2023 (SDES)

**TCA** — *À retenir :* Anorexie ≈ 0,9 % des femmes, boulimie ≈ 1,5 %, hyperphagie ≈ 3,5 % (vie entière) ; prévention sans poids ; repérer et orienter (FFAB)

**Précarité** — *À retenir :* Stratégies : qualité sacrifiée, priorité aux enfants, faire durer, aide alimentaire, plaisir préservé ; reconnaître les compétences

# Fiches-outils du chapitre 4

**Outil · Intitulé · Utilité**

**O4.1** — *Intitulé :* Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe ; *Utilité :* Adapter l'action aux pratiques (régimes, religions, rythmes)

**O4.2** — *Intitulé :* Échelle de la faim et de la satiété ; *Utilité :* Atelier sensations (enfants, adultes)

**O4.3** — *Intitulé :* Grille d'analyse d'un comportement alimentaire ; *Utilité :* Identifier déterminants et dérégulations

**O4.4** — *Intitulé :* Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe ; *Utilité :* Choisir des recettes communes

**O4.5** — *Intitulé :* Repérage et orientation (signes d'alerte) ; *Utilité :* Conduite à tenir en action collective

## O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe

| Pratique | Nombre de participants | Conséquence pour l'atelier |
|---|---|---|
| Sans porc / halal | | |
| Casher | | |
| Végétarien / pescétarien | | |
| Végétalien | | |
| Jeûne (période, horaires) | | |
| Allergies (préciser) | | |
| Intolérances, maladie cœliaque | | |
| Textures adaptées | | |
| Autre | | |

*Recueil avec l'accord des personnes ; données de santé à protéger (RGPD).*

## O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété

**Niveau · Ce que je ressens · Que faire ?**

**0** — *Ce que je ressens :* Très faim, malaise, irritabilité ; *Que faire ? :* Manger sans attendre

**2** — *Ce que je ressens :* Faim nette, ventre qui gargouille ; *Que faire ? :* C'est le bon moment pour manger

**4** — *Ce que je ressens :* Petit creux ; *Que faire ? :* Je peux manger ou attendre un peu

**5** — *Ce que je ressens :* Ni faim ni rassasié ; *Que faire ? :* Pas besoin de manger

**7** — *Ce que je ressens :* Rassasié, satisfait ; *Que faire ? :* C'est le bon moment pour s'arrêter

**9** — *Ce que je ressens :* Trop mangé, ventre lourd ; *Que faire ? :* Repérer ce qui m'a poussé à continuer

**10** — *Ce que je ressens :* Mal, nausée ; *Que faire ? :* Prendre le temps la prochaine fois

## 04.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire

| Rubrique | Observations |
|---|---|
| Comportement observé (quoi, quand, | |
| combien, où, avec qui) | |
| Rôles de l'acte alimentaire en jeu | |
| Régulation (faim, rassasiement, satiété | |
| respectés ?) | |
| Dérégulations possibles (restriction, | |
| émotionnelle, externalité, grignotage) | |
| Déterminants (biologiques, | |
| psychologiques, sociaux, économiques, | |
| environnement) | |
| Leviers éducatifs et environnementaux | |
| Signes d'alerte nécessitant une | |
| orientation | |

orientation

## 04.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe

| Recette | Sans porc / halal | Végétarien | Végétalien | Sans gluten | Sans lait | Allergènes à signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |

## 04.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir

**Signe observé ou confié · Conduite à tenir**

**Perte de poids importante, restriction sévère, peur intense de grossir** — *Conduite à tenir :* Ne pas commenter devant le groupe ; en parler en privé avec bienveillance ; informer le référent de la structure ; orienter vers le médecin traitant

**Crises de « craquage », vomissements, utilisation de laxatifs** — *Conduite à tenir :* Même conduite ; informer des ressources (médecin, structures spécialisées en TCA)

**Perte d'appétit et de poids chez une personne âgée** — *Conduite à tenir :* Signaler (avec accord) au médecin traitant ou au service d'aide ; proposer une pesée

**Pathologie déclarée (diabète, insuffisance rénale…)** — *Conduite à tenir :* Orienter vers une consultation diététique (BC1), ne pas prescrire de régime

**Détresse psychologique** — *Conduite à tenir :* Informer immédiatement le référent ; ressources d'écoute ; ne pas rester seul(e)